



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : امال فؤاد عوف مصطفى

المحافظة : الجيزة الحي / المدينة : العمرانية

العنوان : 4 ش محمد السيسي - تقسيم اباطه

تاريخ تسجيل الإستمارة : 30-09-2026

رقم البطاقة : 25310080103208 رقم التليفون : 01063549335

العمر (تاريخ الميلاد) : 08-10-1953 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

المقر بما فيه التوقيع: (-----)

الإحصائي الاجتماعي التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

قسم العلاج :
الأورام

خطة العلاج : أبحاث أورام اشعه مقطعيه علي البطن والصدر والحوض بالصبغه [11127]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني الوظيفة: ----- التوقيع: -----
الاسم: د/ندى حسن الوظيفة: ----- التوقيع: -----
الاسم: د/نرمين رمضان الوظيفة: ----- التوقيع: -----

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. ----- /د. ----- /د. ----- /د. -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
جهة العلاج : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: امال فؤاد عوف مصطفى National ID: 25310080103208	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالثدي و تحتاج الي Contrast-enhanced CT Chest & abdomen and pelvis
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

إمال

فؤاد عوف مصطفى

ش محمد الميسى تقسيم اباظه
العمرانية - الجيزة

١٩٥٣/١٠

٢٥٣١٠٠٨٠١٠٣٢٠٨

LX5132009

١٠٦٢٥٤٩٢٣٥
١٠٨٢٤٠٨٢٨

٩/٢٠



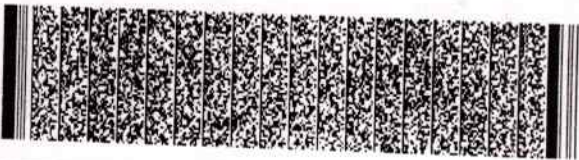
٢٠٢٦/٠٨ ٢٥٣١٠٠٨٠١٠٣٢٠٨

ربة منزل



أنثى مسلمة
عبدالرحمن سيد على السيد

البطاقة سارية حتى ٢٠٣٣/٠٨/٠٤



Patient Name

امال فؤاد عوف

Date

: 13/9/2026

BILATERAL BREASTS SONOGRAPHY

- Normal skin and subcutaneous tissue of left breast.
- Left breast shows normal parenchymal echopattern with fibroglandular pattern.
- A large ill-defined irregular shaped iso- to hypoechoic lesion with peripheral irregularity is seen at retro-areolar region of Rt breast , It measures 25 x 14 mm in dimensions with internal vascularity and acoustic shadowing , It casts post acoustic enhancement. It is associated with nipple retraction as well as tissue interstitial edema

OPINION

- *Rt breast retro-areolar large lesion with nipple retraction as well as tissue interstitial edema as described....? Phylloid tumor for True cut biopsy as it is more confirmative (BIRADS IV a) .*

يوجد في الثدي
نipple retraction
تحت ملاحظة

Best regards.

DR. Sherien Hassan



جمهورية مصر العربية
مطابقة تحقيق الشخصية

أمال
شؤاد عوف مصطفى
٤ ش محمد السيسى تقسيم اياظه
العمرانية - الجيزة

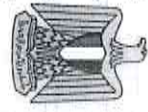
٢٥٣١٠٠٨٠١٥٢٢٠٨

١٩٥٣/١٠

LX5132009



٢٠٢٦/٠٨ ٢٥٣٨٠٠٨٠١٠٣٢٠٨
ريّة منزل
اشق
مسلمة
متروجة
عبدالرحمن سيد علي السيد
البطاقة سارية حتى: ٢٠٣٢/٠٨/٠٤





Patient Name

امال فؤاد عوف

Date

: 13/9/2026

BILATERAL BREASTS SONOGRAPHY

- Normal skin and subcutaneous tissue of left breast.
- Left breast shows normal parenchymal echopattern with fibroglandular pattern.
- A large ill-defined irregular shaped iso- to hypoechoic lesion with peripheral irregularity is seen at retro-areolar region of Rt breast, It measures 25 x 14 mm in dimensions with internal vascularity and acoustic shadowing, It casts post acoustic enhancement. It is associated with nipple retraction as well as tissue interstitial edema

• OPINION

- Rt breast retro-areolar large lesion with nipple retraction as well as tissue interstitial edema as described....? Phylloid tumor for True cut biopsy as it is more confirmative (BIRADS IV a).

Phylloid tumor

Best regards,

DR. Sherien Hassan





N H T M R I

قسم الباثولوجي

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي
والأمراض المعديةPATHOLOGY DEPARTMENT
HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: أمل فؤاد عوف مصطفى	Age: 73 years	Sex: female
Request type: مبادره	Sub request type:	
Hospital no:	Pathology no.:1000-2026	
Department: صحة مرآه	Date of result:27/9/2026	
Referred by: د/مروه حسن	Date of biopsy:20/9/2026	
Nature of specimen: tru-cut biopsy	I.D. Number:25310080103208	

Clinical diagnosis: Right breast mass

Gross pathology :

Multiple fragmented grayish white tissue cores up to 1cm long, totally submitted.

Immunohistochemical Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against: ER- PR- Her2- Ki67

Microscopic picture:

Section examined revealed core of tumor showing invasive duct carcinoma of no special type (NST). The tumor forms nests, tubule and cribriform pattern infiltrating among desmoplastic stroma. Tumor cells showing moderate anaplasia and moderate tendency to from tubules. There is moderate number of mitotic figures.

Immunohistochemical Result

ER: Strong nuclear staining in 90 % of tumor cells (Allred Score 8/8).

PR: Weak nuclear staining in 70% of tumor cells (Allred Score 6/8).

Her2: Weak incomplete membranous staining in >10% of tumor cells (score 1+).

Ki67: Positive nuclear staining of 50% of tumor cells.

Diagnosis: Right breast mass ,Tru-cut biopsy :

Invasive duct carcinoma (NST), Grade II.

Signature:

Dr.Nermine Nabil.M.D

Dr. N
27/9/2026

Pathology Lab. Manager

BASMA REFAAT M.D

Patient Name

امال فواد عوف

Date

: 13/9/2026

BILATERAL BREASTS SONOGRAPHY

- Normal skin and subcutaneous tissue of left breast.
- Left breast shows normal parenchymal echopattern with fibroglandular pattern.
- A large ill-defined irregular shaped iso- to hypoechoic lesion with peripheral irregularity is seen at retro-areolar region of Rt breast , It measures 25 x 14 mm in dimensions with internal vascularity and acoustic shadowing , It casts post acoustic enhancement. It is associated with nipple retraction as well as tissue interstitial edema

• OPINION

- *Rt breast retro-areolar large lesion with nipple retraction as well as tissue interstitial edema as described....? Phylloid tumor for True cut biopsy as it is more confirmative (BIRADS IV a).*

Best regards,

DR. Sherien Hassan

د/شهرين حسن
13/9/2026
امال فواد عوف



Patient Name

امال فواز عوف

Date

: 13/9/2026

BILATERAL BREASTS SONOGRAPHY

- Normal skin and subcutaneous tissue of left breast.
- Left breast shows normal parenchymal echopattern with fibroglandular pattern.
- A large ill-defined irregular shaped iso- to hypoechoic lesion with peripheral irregularity is seen at retro-areolar region of Rt breast, It measures 25 x 14 mm in dimensions with internal vascularity and acoustic shadowing, It casts post acoustic enhancement. It is associated with nipple retraction as well as tissue interstitial edema

• OPINION

- *Rt breast retro-areolar large lesion with nipple retraction as well as tissue interstitial edema as described....? Phylloid tumor for True cut biopsy as it is more confirmative (BIRADS IV a).*

Best regards,

DR. Sherien Hassan